

Pratique neuroaffirmative



Formation Professionnel·le·s de l'Autisme · Centre Régional d'Éducation et de Services pour l'Autisme

Capucine Rebours

capucine.rebours@gmail.com; capucine.rebours@univ-tlse2.fr

Trouble du spectre de la neuroatypie

Critères diagnostiques

- A. Déficits persistants dans la communication socio-émotionnelle dans différents contextes** : comportements inauthentiques et ritualisés (besoin pathologique de répéter le schéma de salutation ritualisé : “salut, ça va ? – Oui et toi ? Bien”); manque de précision et de logique dans la communication verbale et non-verbale ; incapacité à tolérer le silence ; utilisation compulsive de mensonge social.
- B. Schémas de comportement vagues et socialement dépendants** : résistance pathologique aux transgressions sociales; détresse face à la non-conformité; intérêts volatils et superficiels ; indifférence apparente aux expériences sensorielles.
- D. Ces symptômes causent une détresse cliniquement significative...** lorsque la personne est placée dans un environnement neurodivergent normal.

Qu'est-ce que vous venez de lire ?

Où est le “problème” ?

Un fil rouge pour traverser les modèles

Biomédical

Dans le cerveau

Psychanalytique

Dans l'histoire psychique

Social / Neurodiversité

Dans l'environnement
et dans le regard

*Ces modèles ne sont pas neutres : ils définissent qui a le “problème”,
qui doit changer, et au bénéfice de qui.*

Modèle biomédical

Le problème est dans le cerveau



Ce que ce modèle postule

- Il existe un fonctionnement “normal” et un fonctionnement “pathologique”
- L'autisme = écart à cette norme = déficit à corriger
- Objectif thérapeutique : normalisation et guérison
- Illustration : théorie de l'esprit (Baron-Cohen, 1991) l'autisme comme déficit cognitif intrinsèque
- La personne est "manquante" de quelque chose

Ce qu'il a apporté

- Caractérisation
- Outils de repérage
- Accès au diagnostic

Ce qu'il invisibilise

- Les forces, les compétences, les variations légitimes
- La priorité : "guérir" plutôt qu'améliorer la qualité de vie

Modèle psychanalytique

Le problème est dans l'histoire psychique

Bettelheim, Lacan, Dolto

Autisme = psychose infantile
"Mères réfrigérateurs"

Versions contemporaines

Incapacité à différencier soi/autrui
Bloquage dans le développement psychosexuel

Aujourd'hui en France

HAS 2026 : ne recommande pas la psychanalyse
Mais encore enseignée dans les universités

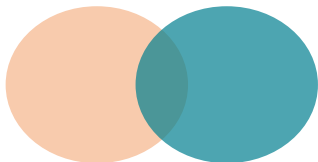
Point commun avec le biomédical : l'idée qu'il serait possible et souhaitable de "guérir" l'autisme.

Modèle social & Neurodiversité

Le problème est dans l'environnement, puis dans le regard

Modèle social du handicap

- Le handicap n'est pas dans la personne mais dans l'environnement inadapté (Oliver, 1990)
- Obstacles institutionnels, culturels, relationnels
- Validisme : système qui hiérarchise les fonctionnements
- Limite : peut minimiser des souffrances intrinsèques réelles
- **Modèle relationnel : handicap = interaction personne × environnement**

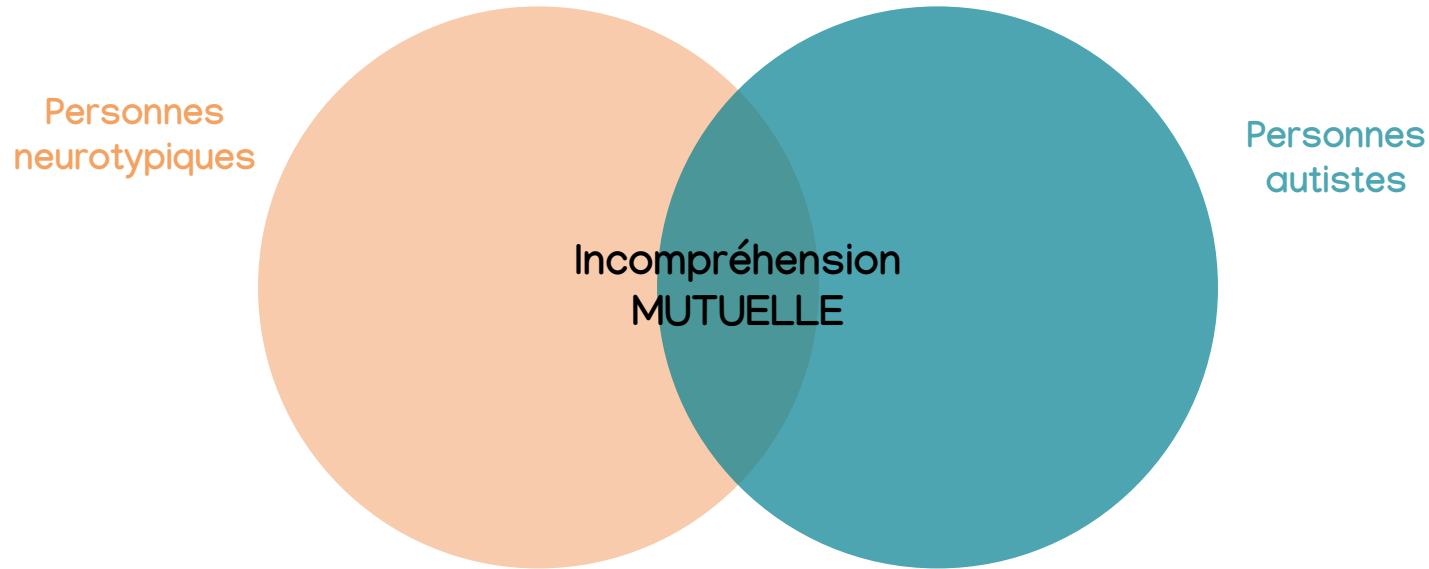


Paradigme de la neurodiversité

- La diversité neurologique fait partie de la variation humaine normale (Singer, 1998) = **neurodiversité**
- Les personnes autistes ne sont pas déficientes, elles sont différentes
- La souffrance naît du rejet et des normes imposées, pas du fonctionnement lui-même
- "Don't Mourn For Us" – Jim Sinclair, 1993
- Ne nie pas les besoins de soutien réels

La théorie de la double empathie

Milton, 2012



La norme reste celle des neurotypiques →
le déficit paraît unilatéral alors qu'il est réciproque.

Crompton et al. (2020) : la communication est plus efficace entre personnes autistes qu'entre une personne autiste et une personne neurotypique.

Trouble du spectre de la neuroatypie

Critères diagnostiques

- A. Déficits persistants dans la communication socio-émotionnelle dans différents contextes** : comportements inauthentiques et ritualisés (besoin pathologique de répéter le schéma de salutation ritualisé : “salut, ça va ? – Oui et toi ? Bien”); manque de précision et de logique dans la communication verbale et non-verbale ; incapacité à tolérer le silence ; utilisation compulsive de mensonge social.
- B. Schémas de comportement vagues et socialement dépendants** : résistance pathologique aux transgressions sociales; détresse face à la non-conformité; intérêts volatils et superficiels ; indifférence apparente aux expériences sensorielles.
- D. Ces symptômes causent une détresse cliniquement significative...** lorsque la personne est placée dans un environnement neurodivergent normal.

Qu'est-ce que vous venez de lire ?

Retour sur le texte du début

- A. **Déficits persistants dans la communication socio-émotionnelle dans différents contextes :** comportements inauthentiques et ritualisés (besoin pathologique de répéter le schéma de salutation ritualisé : “salut, ça va ? – Oui et toi ? Bien”); manque de précision et de logique dans la communication verbale et non-verbale ; incapacité à tolérer le silence ; utilisation compulsive de mensonge social.
- B. **Schémas de comportement vagues et socialement dépendants :** résistance pathologique aux transgressions sociales; détresse face à la non-conformité; intérêts volatils et superficiels ; indifférence apparente aux expériences sensorielles.

Le "Neurotypical Spectrum Disorder" applique la logique déficitaire du DSM à la neurotypicalité pour en montrer l'arbitraire. Ce n'est pas "les neurotypiques ont aussi des déficits" : c'est "la logique déficitaire elle-même est une construction."

"My ways of being are not merely damaged versions of yours."

Jim Sinclair, 1993

Autiste, co-fondateur du mouvement pour les droits des personnes autistes

Si ce cadre change → qu'est-ce que ça change dans votre pratique ?

La pratique neuroaffirmative

La posture fondamentale

01

Le handicap n'est pas dans la personne

Il vient de l'interaction entre son fonctionnement et un environnement non conçu pour elle.

02

Il n'y a rien à guérir

L'autisme n'est pas une pathologie. C'est une différence d'organisation neurologique interprétée comme pathologie parce que minoritaire.

03

Toutes les façons d'être sont valides

Il n'y a pas une façon d'être humain plus acceptable que les autres. On ne normalise pas: on adapte, on soutient, on légitime.

04

Un processus, pas une destination

Ce n'est pas un label à cocher. C'est un engagement continu de désapprentissage et de remise en question de ses propres pratiques.

Exercice

En petits groupes – 10 minutes

Vous venez de lire le compte-rendu d'un suivi rédigé par une psychologue qui s'inscrit dans une pratique neuroaffirmative.

Identifiez les principes de la pratique neuroaffirmative que vous repérez dans ce texte.

Qu'est-ce que la psychologue fait ?

Pourquoi est-ce neuroaffirmatif ?

Quel principe de la pratique neuroaffirmative peut-on identifier ?

Question centrale : qu'est-ce que ces gestes disent du regard que la psychologue pose sur Léa ?

Note de suivi clinique – Léa, 17 ans

Psychologue libérale · Synthèse des premières séances

Léa m'a été adressée à 17 ans, quelques mois après un diagnostic de TSA posé tardivement, pour des épisodes de shutdown répétés en milieu scolaire. Je ne connaissais pas bien ce fonctionnement : j'ai pris le temps de me former spécifiquement avant les premières séances, en consultant des ressources produites par des personnes autistes. Cette formation a modifié significativement ma compréhension.

Les premières séances ont été silencieuses de sa part. Léa arrivait avec sa mère, qui répondait à mes questions à sa place. J'ai fait le choix de continuer à m'adresser directement à Léa, même lorsqu'elle ne répondait pas verbalement, sans interpréter son silence comme une incapacité à s'engager. Je lui ai proposé de communiquer par texto pendant les séances si c'était plus accessible. C'est ce format qu'elle a choisi pendant les deux premières semaines, avant de trouver progressivement sa façon de prendre la parole.

Léa a vécu une situation de harcèlement scolaire intense l'année précédente, qui a conduit à un changement d'établissement. Elle a décrit cette période avec beaucoup de prudence, testant visiblement si je la croirais. J'ai veillé à ne jamais relativiser ce qu'elle décrivait. Ce qu'elle a vécu était réel, et la peur que ça se reproduise est une réponse cohérente à ce traumatisme, pas un symptôme à corriger. Je l'ai nommé ainsi devant elle.

Sa mère exprimait régulièrement l'inquiétude que Léa "donne une mauvaise image" et devrait faire des efforts pour s'adapter socialement. Léa, elle, dit qu'elle "s'en fout du regard des autres", qu'elle assume d'être visiblement autiste. J'ai validé cette position. Être visiblement autiste n'est pas une invitation au harcèlement, et la responsabilité du harcèlement repose sur les harceleurs. J'ai encouragé cette fierté plutôt que de la tempérer.

J'ai tout de même ouvert la question : est-ce qu'il y a des choses autour du harcèlement sur lesquelles elle voudrait travailler ? Elle m'a dit clairement que ce n'était pas sa priorité. J'ai acté ce choix sans insister. Elle a ajouté qu'elle aimerait un jour apprendre à répondre aux piques verbales. J'ai noté cette demande. Nous y reviendrons quand elle le souhaitera, selon ses termes et à son rythme.

Ce suivi me demande une vigilance particulière sur mes propres réflexes. Il m'arrive encore de vouloir rassurer la mère, de vouloir proposer des stratégies d'adaptation qui viseraient implicitement à rendre Léa plus conforme. Je me reprends. Mon travail ici n'est pas d'aider Léa à ressembler davantage à ce que les autres attendent.

Principes – La posture de psychologue

Ce qui se passe avant la séance, et pendant



Apprentissage continu

Prioriser les ressources produites par des personnes autistes. Questionner l'origine du savoir : par qui, depuis quelle position ?



Approche informée sur le trauma

La plupart des personnes autistes arrivent avec un historique de victimisation et de stigmatisation. Personne n'entre sans bagages.



Reconnaître les limites des outils et des termes

Les outils de mesure standardisés ont été conçus pour des populations neurotypiques. Ils peuvent mal capturer le fonctionnement autistique. Éviter les formulations déficitaires. Utiliser les termes des personnes elles-mêmes.



Auto-réflexivité permanente

Identifier ses biais sur ce que les personnes "devraient" faire ou ressentir. L'humilité doit se pratiquer quotidiennement.

Principes – La relation thérapeutique

Ce qui se construit dans l'espace clinique

Présumer la compétence

Partir du principe que la personne peut apprendre, penser, évoluer. Chercher les soutiens nécessaires, pas les limites supposées.

Valider les expériences

Croire ce que la personne dit de son vécu.
La traiter comme l'experte de sa propre vie.

Respecter l'autonomie

Autonomie corporelle, définition des objectifs, choix des stratégies.
La personne décide de ce qui l'aide.

Trouver une façon de communiquer

Temps de traitement, modalités alternatives, pas de contact visuel imposé. Ne pas interpréter la lenteur ou le silence.

Ne pas promouvoir le camouflage

Interroger systématiquement : si cet objectif vise à rendre la personne moins visible, **au bénéfice de qui ?**

Soutenir l'identité autiste positive

Aider la personne à se connecter à la communauté autiste et à ses propres forces.

Concrètement

L'environnement de soin

- Accueillir le stimming, ne pas exiger le contact visuel, adapter l'environnement sensorial
- Prévisibilité : rappels, horaires cohérents, anticiper les changements
- Honorer toutes les formes de communication : la parole n'est pas la forme supérieure
- Plaider pour des changements systémiques : rien sur nous sans nous

Ce qui n'est pas neuroaffirmatif

L'objectif d'indistinguabilité

Rendre une personne autiste "normale" aux yeux des autres

La suppression du stimming

Le stimming est une fonction autorégulatrice légitime

Les habiletés sociales neurotypiques enseignées comme la norme

Enseigner des codes neurotypiques sans recul = promouvoir le camouflage

Les approches de conformité comportementale

On n'enseigne pas l'obéissance et la conformité

Exercice pratique – Lucas, 12 ans · Stéréotypes

Lucas, 12 ans, autiste, scolarisé en classe ordinaire avec AVS. Il se balance sur sa chaise et s'agite les mains lorsqu'il travaille.

Son enseignante dit que ça distrait les autres élèves et demande à l'AVS de lui rappeler de "rester tranquille" chaque fois que ça arrive.

Lucas obtient de bons résultats scolaires quand on le laisse travailler à son rythme.

Qu'est-ce que vous faites de cette demande de l'enseignante ?

"À qui bénéficie cette intervention ?"

Le balancement aide Lucas à travailler. La demande bénéficie à l'enseignante, pas à Lucas.

Aménager l'environnement

Fidget toy, placement au fond de la classe, vérifier si la chaise grince.
Adapter, pas supprimer.

Consulter Lucas

Lui demander pourquoi il a besoin de se balancer, valider son vécu, lui expliquer la situation, co-construire une solution.

Exercice pratique – Ismaël, 9 ans · Intérêts spécifiques

Ismaël, 9 ans, autiste, suivi en SESSAD. Il est passionné par les cartes Pokémon depuis l'âge de 4 ans. Il ramène les Pokémon dans toutes les conversations et refuse de parler d'autre chose avec les professionnels.

Son éducatrice propose d'utiliser les Pokémon comme "renforçateur" lorsqu'il réussit un exercice pour qu'il accepte de travailler sur d'autres compétences.

Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, et qu'est-ce que vous feriez à la place ?

Instrumentaliser vs. partir de

Utiliser les Pokémon comme "carotte" pour obtenir une conformité, c'est très différent de construire les apprentissages sur ce qui a du sens pour Ismaël.

Qui a défini les objectifs ?

Ces "autres compétences" à travailler : qui les a définies, et pourquoi ? Ismaël a-t-il été consulté sur ce qu'il voudrait apprendre ?

Valider l'intérêt

Parler de Pokémon n'est pas un refus de travailler. C'est une façon d'être en relation. L'intérêt n'est pas une monnaie d'échange.

Exercice pratique – Sonia, 34 ans · Effondrement

Sonia, 34 ans, autiste, suivie en libéral après un burnout autistique. Elle arrive en séance après une journée de travail en open space. Elle est mutique, ne répond pas aux questions, se recroqueville sur elle-même.

Son responsable demande un certificat attestant qu'elle est apte à travailler en collectif.

Qu'est-ce qui se passe pour Sonia, et comment vous positionnez-vous face à la demande de son responsable ?

Ce n'est pas une crise à gérer

C'est un effondrement après surcharge. Être présent·e sans exiger. Adapter le cadre immédiat : silence, lumière, confort sensoriel.

La demande du responsable

Certifier l'aptitude sans questionner l'environnement, c'est placer la responsabilité sur Sonia. L'open space produit l'effondrement.

Aménagements de poste et autonomie

Accompagner Sonia dans la formalisation de ses besoins : télétravail, espace calme, casque. C'est elle qui décide ce qu'elle veut faire.

Pour retenir

***"My ways of being are not merely
damaged versions of yours."***

Jim Sinclair, 1993

L'autisme n'est pas un déficit à corriger, mais une différence à reconnaître

Le handicap est produit par l'interaction entre un fonctionnement et un environnement inadapté

La pratique neuroaffirmative est une posture, pas une technique

Vous la pratiquez déjà : maintenant vous pouvez la nommer